

1.

ЗАГРОЗА ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ

Сценарій.

Ви лікар акушер - гінеколог. До вас на прийом звернулася вагітна жінка 25 років. Вагітність I, 28 тижнів. Скарги на болі унизу живота. З перенесених захворювань відмічає ГРВЗ, дитячі інфекції. Менструальна функція до вагітності не порушена. Загальний стан задовільний. Серцево-судинна та дихальна системи без порушень. Матка в підвищеному тонусі. Спинка плода ліворуч та допереду. Передлежить голівка плода. ЧСС плода 136 у хв. Виділення із статевих шляхів слизові. При піхвовому дослідженні шийка вкорочена, зовнішнє вічко закрите. Визначити результат клінічного аналізу крові, сечі та ультразвукового дослідження. Встановити провідний синдром, попередній діагноз і визначити подальший шлях пацієнтки. Розробити заходи щодо профілактики здорового способу життя та врахувати легальні етичні аспекти ведення пацієнтки.

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення
Гемоглобін (г/л)	120
еритроцити ($10^{12}/л$)	3,7
Кольоровий показник	0,89
Тромбоцити ($10^9/л$)	235,5
ШЗЕ (мм/год)	25
Лейкоцити ($10^9/л$)	6,3
Лімфоцити %	20
Еозинофіли %	0
Паличкоядерні нейтрофіли %	6
Сегментоядерні нейтрофіли %	71
Моноцити %	3

Клінічний аналіз сечі

Показник	Значення
Кількість	60 мл
Колір	Світло-жовтий
Прозорість	прозора
Питома вага	1,002
Білок	немає
Цукор	немає
Мікроскопія сечового осаду	
Лейкоцити	5-6 у п/з
Еритроцити	1-2 екз у п/з
Циліндри гіалінові	немає

Солі	немає
Слиз	немає
Бактерії	немає

Ультразвукове дослідження вагітності



Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнткою, встановлення контакту.	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.Моє ім'я...
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	Сказати Ви даєте свою згоду на проведення клінічного дослідження (Будемо вважати що згода отримана)
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	Сказати Обробляю руки на гігієнічному рівні, дбаю про власну безпеку (одягаю маску та рукавиці) Будемо вважати, що руки оброблені
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнтки	Сказати: «Які у вас скарги?» Очікуваний відповідь: «Біль унизу живота.»
2.2	Анамнез життя	Сказати: «Які захворювання ви перенесли?» Очікувана відповідь: «ГРВЗ, дитячі інфекції.»

2.3	Менструальна функція	Сказати: «Чи були порушення менструального циклу до вагітності?» Очікувана відповідь: «Ні»
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	Сказати: Стан задовільний, серцево-судинна та дихальна системи: без порушень.
3.2	Акушерське обстеження	Сказати: Матка в підвищеному тонусі. Спинка плода ліворуч та донеду. Передлежання головне. ЧСС плода 136 уд./хв. Виділення слизові.
3.3	Піхвове дослідження	Сказати: Шийка вкорочена. Зовнішнє вічко закрито. Виділення слизові.
3.4	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Сказати «Як Ви себе відчуваєте?» Очікувана відповідь: добре
4. Діагностика		
4.1	Визначити результат клінічного аналізу крові	Сказати: норма
4.2	Визначити результат клінічного аналізу сечі	Сказати норма
4.3	Визначити результат ультразвукового дослідження	Сказати- відповідає терміну вагітності
4.4	Визначити провідний синдром	Сказати- больовий
4.5	Встановити клінічний діагноз	Сказати : Вагітність 28 тиж. І позиція, передній вид, головне передлежання. Загроза передчасних пологів.
5. Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення вагітної	Сказати : госпіталізація у стаціонар для збереження вагітності
6. Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати :- Спокійний режим, уникнення фізичних навантажень. - Раціональне харчування (білки, залізо, вітаміни).
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	Сказати- Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при вашому стані. У вашому випадку матковий тонус може свідчити про загрозу передчасних пологів